היפונתרמיה

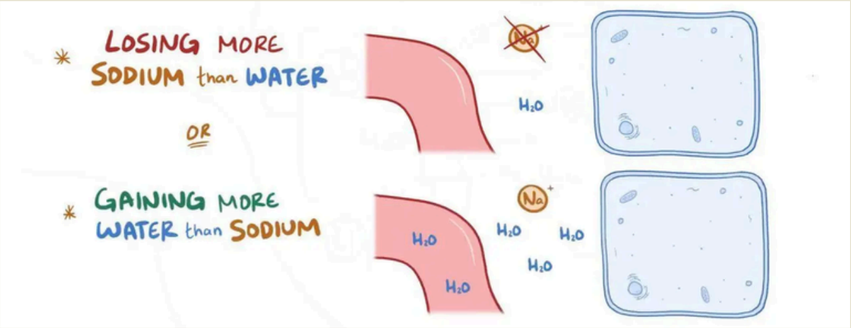
הגדרות ופרוטקול תיקון

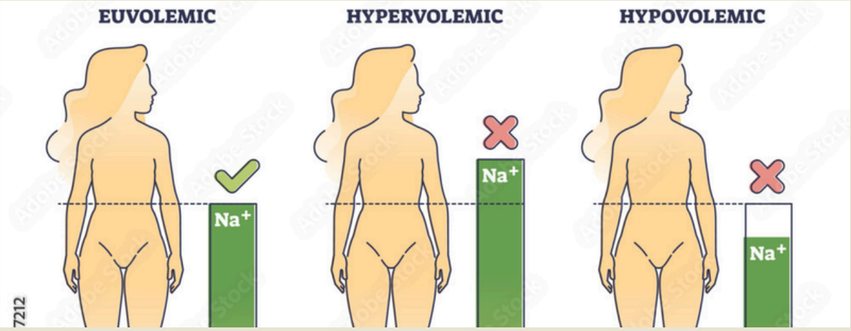
מלר"ד עין כרם
רוני זפרני

נובמבר 2024

סוגי היפונתרמיה

היפונתרמיה





01 היפונתרמיה היפוטונית

אוסמולליות נמוכה בדם.

- פולידיפסיה ראשונית
- צריכת נתרן מועטה
- אי ספיקת כליות חמורה
- משנית לטיפול במשתנים (תיאזידים)
- הפרשת יתר של ADH (וויליום דם נמוך)
- הפרשת ADH שאינה תואמת למצב הפזיולוגי

יש לבדוק אוסמולריות בדם במידה ויש חשד שלא מדובר בהיפונתרמיה היפוטונית.

02 היפונתרמיה לא היפוטונית

אוסמולליות גבוהה בדם.

- משנית להיפרגליקמיה משמעותית
- משנית לIV MANNITOL
- משנית לטיפול בIVIG

03 היפונתרמיה איזוטונית

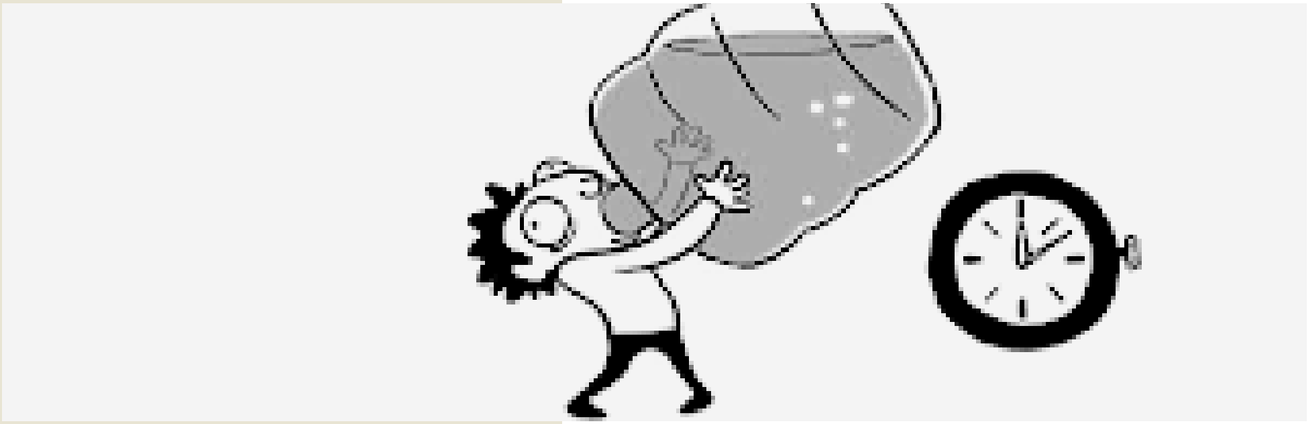
אוסמולליות תקינה- נדיר!

לא מטפלים ב3% NACL

- היפרטריגליצרידמיה
- היפרפרוטאינמיה משמעותית, בעיקר בחולי מיאלומה

הגדרות

היפונתרמיה



01 היפונתרמיה קלה- 130-134MEQ\L

02 היפונתרמיה בינונית- 120-129MEQ\L

03 היפונתרמיה חמורה<120MEQ\L

הגדרות

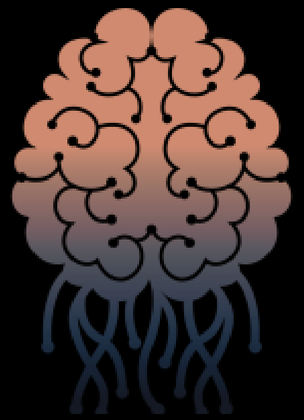
היפונתרמיה

01 **היפונתרמיה אקוטית-** פחות מ48 שעות.
תסמינים- כאבי ראש, בלבול, תשישות, ערפול, פרכוסים, קומה.

02 **היפונתרמיה כרונית-** מעל 48 שעות.
תסמינים- תשישות, בחילות, סחרחורות, הפרעה ביציבה, שכחון, בלבול, התכווצויות שרירים.

תיקון היפונתרמיה

היפונתרמיה



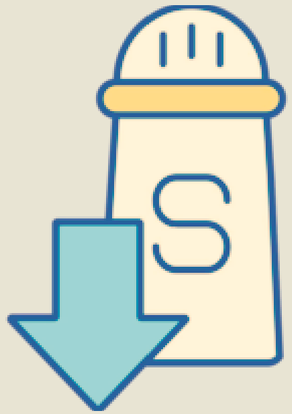
היפונתרמיה בינונית חמורה

הטיפול תלוי במשך ההיפונתרמיה ובהתייצגות (סימפטומטי\א-סימפטומטי)
קצב התיקון לא יעלה על 8-12MEQ\L ב24 השעות הראשונות

היפונתרמיה היפוטונית אקוטית

נתחיל טיפול בהיפונתרמיה<130MEQ\L סימפטומטית.

- NACL 3% 100ML במשך 10 דק'
- לבצע בדיקת דם לרמת נתרן כל 30 דק,
- ניתן לחזור על המתן במידה והסימפטומים ממשיכים



היפונתרמיה היפוטונית כרונית

נתחיל טיפול בהיפונתרמיה<120MEQ\L, סימפטומים חמורים או הסטוריה של תחלואה אינטרקרניאלית. חשוב לברר את הגורם להיפונתרמיה!

- NACL 3% 100ML במשך 10 דק'
- ניתן לחזור על המתן עד ל3 פעמים כל 30 דק
- אם נתרן<125MEQ\L יש לבדוק רמת נתרן בדם כל 3 שעות

הפסקת טיפול

היפונתרמיה

קריטריונים להפסקת הטיפול ב3% NACL-

- הופעת שיפור בסימפטומים או הפסקתם
- התחלת טיפול בגורם
- אם קצב הטיפול מהיר מ2MEQ\L לשעה
- אם קצב הטיפול מהיר מ6MEQ\L ב8 השעות הראשונות
- לאחר 8 שעות אסור שקצב הטיפול יעלה על 0.5MEQ\L לשעה או 12MEQ\L ב24 השעות הבאות
- במידה וקצב התיקון מהיר מידי- יש להתייעץ עם נפרולוג ולשקול מתן DEX 5%

טיפול סיעודי

היפונרתמיה

01 ניטור מדדים חיוניים

02 מתן NACL 3% בבירטה בלבד!

03 מעקב אחרי רמת הנתרן בדם

04 הכנסת קטטר

- מעקב אחרי תפוקת שתן
- בדיקת אלקטרוליטים בשתן
- בדיקת אוסמולריות בשתן